

Guide d'administration

Protocole *Panitumumab*

Rédaction : octobre 2013

Révision : avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR chez les patients réfractaires aux chimiothérapies à base d'irinotecan et d'oxaliplatine et qui ont reçu un traitement à base de fluoropyrimidine dont les tumeurs présentent le gène KRAS non muté¹⁻³.

ECOG $\leq$ 2

Visée palliative

- › Évaluation de l'INESSS (1^{er} février 2013) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2013/Vectibix_2013_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (Médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,3}

Le panitumumab est administré par voie intraveineuse une fois toutes les 2 semaines.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration³

Médicament	Dose	Description
Panitumumab	6 mg/kg	› IV soluté; dans 100 mL de NaCl 0,9 % en 60 min. Si la 1^{ère} dose est bien tolérée, les doses subséquentes peuvent être administrées en 30 min. Les doses > 1000 mg, doivent cependant être administrées sur 90 min (concentration finale maximale : 10 mg/mL)^{3,4}. › Via une pompe à perfusion et une tubulure à faible liaison protéique avec filtre de 0,22 microns.
Répéter aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.		
Prémédication obligatoire : aucune		
Considérations spéciales : aucune période d'observation n'est recommandée d'emblée.		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune préalable.
- › **Réactions reliées à la perfusion^{3, 5}** :
 - Rares (3 %) cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Dans moins de 1 % des cas, ces réactions étaient considérées sévères. Aucune prémédication n'est requise d'emblée.
 - Symptômes légers à modérés (grade 1 ou 2) : Réduire la vitesse de perfusion de 50 % pour le reste de cette perfusion. Une prémédication (corticostéroïde et anti-H₁) pourrait être ajoutée pour les cycles subséquents selon le jugement clinique.
 - Symptômes sévères ou mettant la vie du patient en danger (grade 3 ou 4) : cesser immédiatement la perfusion. Si la réaction est sévère ou persistante, il peut être considéré de cesser le panitumumab de façon permanente.
- › **Antéémétiques** : très faiblement émétisant (< 10 %)⁶
 - Pré-chimiothérapie : aucune d'emblée.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention du rash^{3,7,8}**
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool.
 - Employer un savon doux pour le corps et le visage. Garder les ongles courts et propres. Laver le corps et les cheveux au moins une fois par jour. Éviter d'utiliser des produits contre l'acné parce qu'ils assèchent la peau.
 - Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau jusqu'à 2 mois après la dernière dose de panitumumab. Éviter de s'exposer au soleil pendant le traitement et pendant deux mois après l'administration de la dernière dose de panitumumab.

- o Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID)
- o Antibiotique oral (minocycline 100 mg BID ou 50 mg BID, doxycycline 100 mg BID). Débuter la veille du panitumumab pour 6 semaines puis réévaluer.
- o Antibiotique topique (clindamycine 1% crème ou lotion BID). Privilégier la voie orale en prévention.

› **Surveillance du magnésium**

- o L'hypomagnésémie peut se manifester plusieurs jours ou mois après l'instauration du traitement et persister jusqu'à deux mois après le traitement. Jusqu'à 39% des patients présenteront une hypomagnésémie. Elle peut être accompagnée d'hypocalcémie et d'hypokaliémie. Un suivi hebdomadaire du magnésium, potassium et calcium est conseillé pendant le traitement et jusqu'à deux mois après le traitement selon le jugement clinique. Des suppléments *per os* ou intraveineux sont recommandés selon le degré du déficit en électrolytes³.

› **Surveillance des diarrhées⁹ :**

- o Hydratation orale.
- o Pour des diarrhées de grade 1 ou 2, le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- o En cas de diarrhées graves (grade 3 ou 4) ou persistantes, le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale³⁻⁴

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Panitumumab	Aucun ajustement recommandé, non étudié en insuffisance rénale.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique³⁻⁴

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Panitumumab	Aucun ajustement recommandé, non étudié en insuffisance hépatique.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,3}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Panitumumab	Aucun ajustement requis.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique³

Toxicité dermatologique*	Ajustement posologique recommandé		
Grade 1 ou 2	Instaurer ou optimiser les mesures de traitement du rash ^{5,6} . Aucun ajustement de dose requis.		
Grade 3 et plus ou intolérable	Apparition	Action	Ajustement de la dose
	1 ^{ière}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab à 100% de la dose. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	2 ^{ième}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab à 80% de la dose. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	3 ^{ième}	Interrompre le panitumumab pour 1 ou 2 doses	Si amélioration (grade < 3), redébuter panitumumab à 60% de la dose. Sinon arrêter définitivement le traitement.
	4 ^{ième}	Arrêt définitif	----

*Utiliser la version la plus récente de l'échelle CTCAE

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **réactions cutanées** sont l'effet indésirable le plus commun (91 %) du panitumumab. Elles sont habituellement d'intensité légère à modérée, mais peuvent être sévères (grade 3) dans 12 % des cas. Ces réactions surviennent environ 10 jours après le début du traitement et se présentent le plus fréquemment par un érythème, une dermatite acnéiforme et un prurit. Elles apparaissent surtout sur le visage, le haut du dos et la poitrine, mais les extrémités peuvent aussi être touchées. Une paronychie peut également survenir. Rarement, des réactions sévères, telles la fasciite nécrosante et un sepsis sont survenues. Si cela survient, le traitement avec le panitumumab doit être interrompu. En cas de réaction cutanée de grade 3, le panitumumab doit être interrompu et la dose doit être ajustée ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique](#)). Les mesures prophylactiques non pharmacologiques sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{1,3}.

Des **réactions liées à la perfusion** survenant dans les premières 24 heures après le traitement ont été rapportées dans 3 % des cas. Elles se manifestent par des frissons, de la fièvre, de la dyspnée et sont habituellement d'intensité légère. De plus, un cas d'angioœdème fatal est survenu plus de 24 heures après le traitement ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))³.

Des cas d'**hypomagnésémie** ont été rapportés dans 39 % des cas. Elle est habituellement d'intensité légère, mais peut parfois être sévère (5 %). Des cas d'hypocalcémie et d'hypokaliémie ont été rapportés également. Il est important de faire un suivi approprié des électrolytes ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))³.

Le panitumumab est **non-irritant non-vésicant** en cas d'extravasation¹⁰.

Parmi les effets indésirables gastro-intestinaux, les **douleurs abdominales**, l'**anorexie**, les **nausées** et la **diarrhée** sont les plus souvent rapportées dans environ 20 % des cas. Ils sont habituellement d'intensité légère (voir section [2.3 – Thérapie de support](#))^{1,3}.

De rares cas de **maladie pulmonaire interstitielle** sont survenus. Le traitement avec le panitumumab doit être interrompu s'il y a apparition soudaine de symptômes respiratoires ou si ceux-ci s'aggravent³.

De rares cas de **kératite** et kératite ulcéreuse sont survenus avec le panitumumab. Un patient présentant des symptômes oculaires doit être évalué³.

De rares cas de **syndrome de Stevens-Johnson** et d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse ont été signalés ($\geq 1/10\ 000$ patients et $< 1/1\ 000$ patients). Le traitement avec le panitumumab doit être interrompu si ces effets indésirables surviennent.

Tableau des effets indésirables¹

Effet indésirable n=229	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Érythème	64	5	0
Dermatite acnéiforme	62	7	0
Prurit	57	2	0
Exfoliation de la peau	24	2	0
Fatigue	24	4	0
Paronychie	24	1	0
Douleur abdominale	23	7	0
Anorexie	22	3	0
Nausées	22	1	0
Diarrhées	21	1	0
Rash	20	1	0
Fissures de la peau	20	1	0
Constipation	19	3	0
Vomissements	18	2	0
Dyspnée	14	4	1
Pyrexie	14	0	0
Asthénie	14	3	0
Toux	14	0	0
Douleur au dos	10	2	0
Œdème périphérique	10	1	0
Détérioration état général	10	5	2

4.2. Interactions cliniquement significatives³⁻⁵

A ce jour, aucune interaction cliniquement significative n'a été identifiée avec le panitumumab.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustement des doses
Bilan de BASE	Électrolytes (magnésium, potassium, calcium)
Avant chaque traitement (maximum 48h avant le traitement)	Électrolytes (magnésium, potassium, calcium) jusqu'à 8 semaines suivant la fin du traitement

5. Références

1. Custem EV, Peeters M, Siena S et coll. Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best supportive care alone in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2007; 25(13):1658-64.
2. Amado RG, Wolf M, Peeters M et coll. Wild-type KRAS is required for panitumumab efficacy in patients with metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2008; 26(10):1626-1634.
3. Amgen Canada. Monographie du Vectibix®. https://www.amgen.ca/Vectibix_PM_Fre.pdf. Consulté en ligne le 25 avril 2016.
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 25 avril 2016.
5. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 25 avril 2016).
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Marie-Hélène Mailhot. La prise en charge des toxicités cutanées induites par les inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épidermique. *Pharmactuel* 2012; 45(4) : 246-260.
8. Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ et coll. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. *Support Care Cancer*. 2011; 19: 1079-95.
9. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 26 avril 2016, disponible à l'adresse: www.geog.info
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
11. Santé Canada. Vectibix^{MD} (panitumumab) - Cas rares de syndrome de Stevens-Johnson et d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse. 27 mai 2014. <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/39581a-fra.php>